

INDICADO POR: Dr. Riffel	
ACOMPANHAMENTO () CONSULTA	
NS E5424 A06548	
DÉA	
HORACIRA RIBEIRO DE MIRANDA	
IDADE: 81	PESO: 73
ALTURA: 165	PROFISSÃO: Doméstica
SINTOMAS: Cochila bastante / Pernas cansadas.	
*Relata ter bem sono. Dorme rápido	
QUEIXAS: Artrite (eco) / Selo 30K / Sinusite	
MEDICAMENTOS: Duvion / Prisma	
MÉDICO: Dr. Riffel	
MARCAPASSO: () S () IN / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () IN	
EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada / academia ao ar livre	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5	
HORA QUE DORME: 21 HORA QUE ACORDA: 5h	
COCHILO: () S () IN	DORME ACOMPANHADO: () S () IN () EVENTUALMENTE
TEM FILHOS: () S () IN	DORMEM NO QUARTO: () S () IN PET NO QUARTO: () S () IN
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () IN	
FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal	BANHEIRO/NOITE: 1X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: —
OVERLAP: não	MALLAMPATI: IV
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA	
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:	
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA	
(S) ORTOPÉDICA	(N) NEUROLÓGICA () OUTROS:
POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () IN	SPO2 C/ CPAP: 12 PRESSÃO NO EXAME: 90%
31103 Avaliação	
25	
08/04/25	Pn média: 5,9 cm H ₂ O IAH = 4,0 e/h md. uso: 7h 34' fuq: 3' 19s
Ajuste máscara que estava montada errada Aparelho conf. P=12 cm H ₂ O modo C PAP	
Natacha	
29/04/25	P=12 cm H ₂ O IAH = 4,0 e/h md. uso: 12h 15'
Oriento a colocação da máscara	
Natacha	

03/06/25 P=11 cm H₂O

IAH = 2,5 e/h

md de uso: 6h 14'

fuga: 20 min

sem adaptada
Comprim BMC

Natasha

26/06/25 P=10 cm H₂O

IAH = 4,0 e/h

md de uso: 7h 09'

fuga: 21 h/m

Bem adaptada

Natasha

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (19), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**6,7 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina (**80%**);
3. Aumento da latência para o início do sono (**60,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM normal (**90,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono diminuída (**45,1 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**6,9 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**2,0 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Diminuição do percentual do estágio N2 (**49,5 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**22,3 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Aumento do percentual do estágio REM (**26,2 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, constante verificado via sensor de ronco;
12. Presença de atividade em EMG de queixo.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

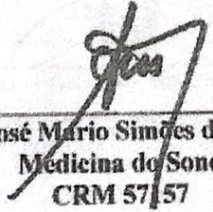
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 12,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157